[5] 中华医学会神经病学分会，中华医学会神经病学分会脑血管病学组. 中国急性缺血性脑卒中诊治指南(2018)[J]. 中华神经科杂志，2018，51(9)：666-682.
[6] 中华医学会神经病学分会，中华医学会神经病学分会脑血管病学组. 中国脑出血诊治指南(2019)[J]. 中华神经科杂志，2019，52(12)：994-1005.
[7] 中华医学会神经病学分会，中华医学会神经病学分会睡眠障碍学组. 中国成人失眠诊断与治疗指南(2017版)[J]. 中华神经科杂志，2018，51(5)：324-335.
[8] 刘红秀，黎东梅. 睡眠质量评估相关参数的调查分析[J]. 广东医学，2017，38(z2)：118-120.
[9] 钱洁，姜敏敏，陈晨，等. 超简抑郁焦虑筛查量表在社区门诊的信度和效度研究[J]. 内科理论与实践，2021，16(2)：116-120.
[10] 陈慧瑛. 职业倦怠量表在手术室护士中应用的信效度检验[J]. 现代实用医学，2018，30(6)：830-831.
[11] 姚永坤，张志强，祁鸣，等. 缺血性脑卒中患者发病后不同时期生活质量的影响因素研究[J]. 中国全科医学，2021，24(33)：4200-4205.
[12] 周仲瑛. 中医内科学[M]. 北京：中国中医药出版社，2004：157-158.
[13] 舒鹰，熊梦清，胡克，等. 三种量表对慢阻肺合并阻塞性睡眠呼吸暂停的筛查价值[J]. 中华医学杂志，2018，98(20)：1574-1577.
[14] 郑筱萸. 中药新药临床研究指导原则(试行)[M]. 北京：中国医药科技出版社，2002：243.
[15] 朱子俊. 亚急性失眠与慢性失眠的多导睡眠图对照研究[D]. 广州：暨南大学，2014.
[16] LI L J，YANG Y，GUAN B Y，et al. Insomnia is associated with increased mortality in patients with first-ever stroke：a 6-year follow-up in a Chinese cohort study[J]. Stroke Vasc Neurol，2018，3(4)：197-202.
[17] GLOZIER N，MOULLAALI T J，SIVERTSEN B，et al . The course and impact of poststroke insomnia in stroke survivors aged 18 to 65 years：results from the psychosocial outcomes in stroke (POISE) study[J]. Cerebrovasc Dis Extra，2017，7(1)：9-20.
[18] 贾莹梅. 针刺四神聪、百会穴对失眠患者血清氨基酸类神经递质影响研究[J]. 中国医药导刊，2016，18(6)：567-568，571.
[19] 王肖煜，谷文龙，李书颖，等. 石学敏“百会、四神聪深纳久留”治疗卒中相关失眠应用浅析[J]. 针灸临床杂志，2023，39(11)：92-96.
[20] 薛靓，于涛，赵晋莹，等. 王富春教授运用四神聪配伍经验[J]. 吉林中医药，2024，44(2)：227-231.
[21] 李花，姚小蓉，郭海鹏，等. 内关穴注射地塞米松对老年高血压患者甲状腺术后恶心呕吐和应激的影响[J]. 实用药物与临床，2024，27(2)：111-115.
[22] 戚美沂. 腹针治疗卒中后轻中度抑郁的临床观察及对肠道菌群的影响[D]. 天津：天津中医药大学，2023.

【责任编辑：宋威，刘彦宜(英文)】

开窍解喑法针刺联合语言训练治疗脑卒中后失语症的临床观察

杨娜，杜佳梦，孙朝霞，董宝鑫，窦京彬
(海军青岛特勤疗养中心综合治疗科，山东青岛 266000)

摘要：【目的】观察开窍解喑法针刺联合语言训练治疗在脑卒中后失语症(PSA)的临床疗效。**【方法】**选取2022年10月至2024年10月海军青岛特勤疗养中心收治的80例明确诊断为PSA的患者为研究对象。按随机数字表将患者随机分为观察组和对照组，每组各40例。对照组给予常规语言训练，观察组在对照组治疗的基础上，给予开窍解喑法针刺治疗。连续治疗4周。治疗1个月后，评价2组临床疗效，观察2组患者治疗前后中医证候积分的变化情况，以及大脑前动脉(ACA)、大脑中动脉(MCA)、大脑后动脉(PCA)血流速度的情况。比较2组患者治疗前后西方失语症成套测验(WAB)量表评分、波士顿诊断性失语症检查法(BDAE)等级评分、脑卒中失语症生活质量(SAQOL-39g)量表评分的变化情况。**【结果】**(1)观察组总有效率为95.00%(38/40)，对照组为80.00%(32/40)，观察组疗效优于对照组，差异有统计学意义($P<0.05$)。(2)治疗后，2组患者的脑血流速度明显改善($P<0.05$)，且观察组在改善脑血流速度方面明显优于对照组，差异有统计学意义($P<0.05$)。(3)治疗后，2组患者的WAB评分、BDAE等级评分明显改善($P<0.05$)，且观察组在改善WAB评分、BDAE等级评分方面明显优于

收稿日期：2025-03-15
作者简介：杨娜(1985-)，女，主治医师；E-mail：tufk002@163.com
通信作者：窦京彬(1969-)，男，副主任医师；E-mail：djb818@sina.com
基金项目：青岛市医药卫生科研计划资助项目(编号：2021-WJZD257)

中国知网 https://www.cnki.net

对照组，差异有统计学意义($P<0.05$)。(4)治疗后，2组患者的中医证候积分、SAQOL-39g评分明显改善($P<0.05$)，且观察组在改善中医证候积分、SAQOL-39g评分方面明显优于对照组，差异有统计学意义($P<0.05$)。**【结论】**开窍解喑法针刺联合语言训练治疗脑卒中失语症，能明显提高患者的脑血流速度，改善患者的临床症状及失语症严重程度，促进患者语言功能恢复，从而提高患者的生活质量，疗效显著。

关键词：针刺；语言训练；脑卒中后失语症；开窍解喑法；语言功能；临床观察
中图分类号：R246.9 **文献标志码：**A **文章编号：**1007-3213(2025)12-3060-07
DOI：10.13359/j.cnki.gzxbtcm.2025.12.022

Clinical Observation of "*Kaiqiao Jieyin*" Acupuncture Method Combined with Language Training in the Treatment of Post-stroke Aphasia

YANG Na, DU Jiameng, SUN Chaoxia, DONG Baoxin, DOU Jingbin
(Dept. of Comprehensive Treatment, Navy Qingdao Special Service Sanatorium, Qingdao 266000 Shandong, China)

Abstract: Objective To observe the clinical efficacy of "*Kaiqiao Jieyin*" acupuncture method combined with language training in the treatment of post-stroke aphasia (PSA). **Methods** A total of 80 patients diagnosed with PSA at the Navy Qingdao Special Service Sanatorium from October 2022 to October 2024 were selected as study subjects. Patients were randomly divided into an observation group and a control group using a random number table method, with 40 cases in each group. The control group received conventional language training, while the observation group received "*Kaiqiao Jieyin*" acupuncture method in addition to the conventional language training. Treatment was administered continuously for 4 weeks. After one month of treatment, the clinical efficacy was evaluated, changes in traditional Chinese medicine (TCM) syndrome scores were observed, and blood flow velocities in the anterior cerebral artery (ACA), middle cerebral artery (MCA), and posterior cerebral artery (PCA) were measured. Changes in Western Aphasia Battery (WAB) scores, Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE) severity ratings, and Stroke Aphasia Quality of Life (SAQOL-39g) scale scores were compared between the two groups before and after treatment. **Results** (1) The total effective rate was 95.00% (38/40) in the observation group and 80.00% (32/40) in the control group, with the observation group showing significantly superior efficacy compared to the control group, the difference being statistically significant ($P<0.05$). (2) After treatment, cerebral blood flow velocities were significantly improved in both groups ($P<0.05$), and the improvement in the observation group was significantly greater than that in the control group, the difference being statistically significant ($P<0.05$). (3) After treatment, WAB scores and BDAE severity ratings were significantly improved in both groups ($P<0.05$), and the observation group showed significantly greater improvement in these scores compared to the control group, the difference being statistically significant ($P<0.05$). (4) After treatment, TCM syndrome scores and SAQOL-39g scores were significantly improved in both groups ($P<0.05$), and the improvement in the observation group was significantly superior to that in the control group, the difference being statistically significant ($P<0.05$). **Conclusion** "*Kaiqiao Jieyin*" acupuncture method combined with language training significantly improves cerebral blood flow velocity, alleviates clinical symptoms and aphasia severity, promotes the recovery of language function, and enhances the quality of life in patients with post-stroke aphasia, demonstrating significant therapeutic efficacy.

Keywords: acupuncture; language training; post-stroke aphasia; *Kaiqiao Jieyin* acupuncture method; language function; clinical observation

脑卒中后失语症(PSA)是由于卒中后导致语言功能障碍的一种疾病，是卒中最常见和最具破坏性的后遗症之一[1]。在全球范围内，每年有超过1 370万例脑卒中患者，其中，失语症影响了超过三分之一的脑卒中幸存者[2]。我国近四分之三的脑血管病患者会出现不同程度的语言功能障碍[3]。失

中国知网 https://www.cnki.net

语症不仅影响患者的生活质量，还对其心理和社会功能造成严重损害。目前，语言训练是治疗PSA的主要方式之一，但其疗程较长且疗效受患者自身影响较大[4]。近年来，中医针刺疗法因其独特的治疗机制和良好的临床疗效越来越受到关注，有关针刺治疗PSA的研究也越来越多[5-6]。“开窍解喑”法是中医针对失语、言语障碍等病症的特色治疗方法，以通络开窍、醒神启语为核心，通过针灸联合中药、综合康复恢复语言功能。本法最早可追溯至《黄帝内经》中“内夺而厥，则为喑痱”。有研究[7]表明，针刺可有效改善患者的语言功能。本研究采用开窍解喑法针刺联合语言训练治疗PSA，取得了显著疗效，现将研究结果报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象及分组

选取2022年10月至2024年10月海军青岛特勤疗养中心收治的80例明确诊断为PSA的患者为研究对象。按随机数字表将患者随机分为观察组和对照组，每组各40例。本研究获医院伦理委员会审议通过，伦理批号：QDTLLL2025-002。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准

参照《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[8]和《失语症(第2版)》[9]的诊断标准拟定。患者在数小时或数天内突然出现面部、手臂或腿部的无力、麻木等，存在语言表达障碍、听或理解障碍等情况。

1.2.2 中医辨证标准

参照《中医病证诊断疗效标准》[10]中的相关诊断标准拟定。主症：半身不遂，不语或言语蹇涩，口舌歪斜，感觉消失或减退；次症：气短乏力，自汗出，面色泛白，舌苔有齿痕或舌苔白腻，舌质暗淡，脉沉细。主症+次症≥2项，舌脉符合即可确诊。

1.3 纳入标准

①符合上述诊断标准；②无听力、视力或意识障碍；③发音器官无受损或病变；④自愿参加本研究并签署知情同意书的患者。

1.4 排除标准

①患有肝、肾等脏器严重功能障碍的患者；②合并有恶性肿瘤的患者；③合并有脑部其他疾病的患者；④有精神病史的患者；⑤治疗过程中病情恶化转为其他治疗方式的患者。

1.5 治疗方法

1.5.1 对照组

给予常规语言训练。治疗前对患者失语症情况及患者个体情况制定训练计划，并给予指导与实施。具体操作方法如下：①呼吸训练：指导患者进行深呼吸和腹式呼吸，增强呼吸功能，为后续发音训练打下基础。②训练发音器官：指导患者将舌头进行反复运动，并通过唇舌操、吹蜡烛、弹珠等运动，来对口唇、舌头及下颌进行训练，为发音及提高发音的准确性做准备。③听理解练习：每天固定时间播放音乐、故事，模拟情景对话或角色扮演等帮助患者提高对声音信号的识别和理解能力，结束后在桌子上摆放训练图片，让患者根据指令指认对应图片。④口语表达训练：从简单的字母、单词，逐步过渡到短句、复杂的句子和对话，护理人员先进行示范，再鼓励患者尝试复述，并根据理解进行表达或扩充。⑤阅读训练：观看影视画面中简单的对话，模仿影视画面中的人物对话，阅读较为简单的文章、句子等，帮助患者提高阅读理解及发声的能力。⑥书写训练：与口语训练一样，从简单的字母逐步到汉字、句子，开始从字帖的描写，到抄写再过渡到独自书写，将带有字体的卡片放到桌子上，让患者观看后翻转，根据记忆进行书写。⑦对话训练：鼓励患者与病友或家属进行日常生活的交流，如相互询问对方的年龄、姓名等，帮助患者提高认知及言语表达能力。语言训练治疗每次30 min，每日1次，共治疗4周。

1.5.2 观察组

在对照组治疗的基础上，给予开窍解喑法针刺治疗。穴位选取：言语一区、言语二区、内关、百会、风池、天突、通里、廉泉、旁廉泉等。具体操作方法如下：患者取仰卧位，采用75%的酒精棉球对穴位局部皮肤进行常规消毒，采用华佗牌一次性使用无菌针灸针(苏州医疗用品厂有限公司生产，规格：0.35 mm × 40 mm)。言语一区、言语二区与头皮呈30°角刺入，当感到指下有松软感时改为与头皮呈15°角刺入0.5～0.8寸；内关穴直刺0.5～1寸；百会穴斜刺0.5～1寸；风池斜刺0.5～0.8寸；天突直刺0.2～0.3寸后向下刺入1～1.5寸；通里直刺0.3～0.5寸；廉泉及旁廉泉斜刺0.5～0.8寸，穴位均采用平补平泻手法。每15 min行1针，留针30 min。行针过程中注意观察患者的反应，及

中国知网 https://www.cnki.net

时调整针刺的深度及刺激强度。针刺治疗每日1次，每周治疗5次为1个疗程，共治疗4个疗程。

1.6 观察指标

1.6.1 中医证候积分

分别于治疗前后观察2组患者中医证候积分的变化情况。中医证候积分评估内容包括半身不遂、口舌歪斜、不语或言语蹇涩、舌质暗淡等，每项分值根据轻、中、重程度分别评分1、2、3分，总分共0～12分。分数越高，则表示病情越严重[11]。

1.6.2 脑血流速度

分别于治疗前后使用血流分析仪检测2组患者大脑前动脉(ACA)、大脑中动脉(MCA)、大脑后动脉(PCA)血流速度的变化情况。

1.6.3 语言功能评估

分别于治疗前后使用西方失语症成套测验(WAB)量表评估2组患者的语言功能。该量表包括自发言语、听理解、复述及命名4个维度，其中，自发言语和听理解总分各200分，复述和命名总分各100分。分数越高，表示患者语言功能越好[12]。

1.6.4 失语症严重程度

分别于治疗前后采用波士顿诊断性失语症检查法(BDAE)对2组患者失语症的严重程度进行评估，分为0～5级共6个等级，分别对应0～5分。分数越低，表示患者失语症越严重[13]。

1.6.5 生活质量评估

分别于治疗前后采用脑卒中失语症生活质量(SAQOL-39 g)量表进行评估。该量表包括生理、沟通、心理社会3个维度，各维度总分分别为80、35、80分，该量表总分195分。分数越高，表示患者生活质量越高[14]。

1.7 疗效判定标准

根据失语症严重程度对其疗效进行判定[15]。治愈：失语指数(AQ)较治疗前降低90%以上；显效：AQ较治疗前降低60%～90%；有效：AQ较治疗前降低30%～59%；无效：AQ较治疗前升高或降低30%以下。总有效率(%)=(治愈例数+显效例数+有效例数)/总病例数×100%。

1.8 统计方法

采用SPSS 23.0统计软件进行数据的统计分析。计量资料采用均数±标准差($\bar{x} \pm s$)表示，组内比较采用配对t检验，组间比较采用独立样本t检验；计数资料采用率或构成比表示，组间比较采用χ^2检验；等级资料组间比较采用Ridit分析。以$P<0.05$表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2组患者基线资料比较

观察组40例患者中：男24例，女16例；年龄48～72岁，平均(59.49±6.37)岁；病程10～68 d，平均(37.18±5.82)d；脑卒中类型：脑出血17例，脑梗死23例。对照组40例患者中：男23例，女17例；年龄47～75岁，平均(61.10±7.03)岁；病程8～70 d，平均(36.91±6.24)d；脑卒中类型：脑出血16例，脑梗死24例。2组患者的性别、年龄、病程等一般情况比较，差异均无统计学意义($P>0.05$)，表明2组患者的基线特征基本一致，具有可比性。

2.2 2组患者临床疗效比较

表1结果显示：观察组总有效率为95.00%(38/40)，对照组为80.00%(32/40)，观察组疗效优于对照组，差异有统计学意义($P<0.05$)。

2.3 2组患者治疗前后脑血流速度比较

表2结果显示：治疗前，2组患者脑血流速度ACA、MCA及PCA比较，差异无统计学意义($P>0.05$)。治疗后，2组患者的脑血流速度ACA、MCA及PCA明显改善($P<0.05$)，且观察组在改善脑血流速度ACA、MCA及PCA方面明显优于对照组，差异有统计学意义($P<0.05$)。

2.4 2组患者治疗前后WAB评分比较

表3结果显示：治疗前，2组患者WAB各维度评分比较，差异无统计学意义($P>0.05$)。治疗后，

表1 2组脑卒中后失语症患者临床疗效比较

Table 1 Comparison of clinical efficacy between the two groups of patients with post-stroke aphasia [例(%)]

组别	例数/例	治愈	显效	有效	无效	总有效
观察组	40	4(10.00)	22(55.00)	12(30.00)	2(5.00)	38(95.00)①
对照组	40	1(2.50)	17(42.50)	14(35.00)	8(20.00)	32(80.00)

注：①$P<0.05$，与对照组比较。

中国知网 https://www.cnki.net

2组患者的WAB各维度评分明显改善($P<0.05$)，且观察组在改善WAB各维度评分方面明显优于对照组，差异有统计学意义($P<0.05$)。

2.5 2组患者治疗前后BDAE等级评分比较

表4结果显示：治疗前，2组患者BDAE等级评分比较，差异无统计学意义($P>0.05$)。治疗后，2组患者的BDAE等级评分明显改善($P<0.05$)，且观察组在改善BDAE等级评分方面明显优于对照组，差异有统计学意义($P<0.05$)。

表2 2组脑卒中后失语症患者治疗前后脑血流速度比较

Table 2 Comparison of cerebral blood flow velocity between the two groups of patients with post-stroke aphasia before and after treatment ($\bar{x}\pm s$, cm·s^{-1})

组别	例数/例	ACA		MCA		PCA	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
观察组	40	41.21 ± 6.02	49.38 ± 5.98①②	49.30 ± 5.82	63.28 ± 7.00①②	35.44 ± 4.85	41.50 ± 4.67①②
对照组	40	41.87 ± 6.71	45.28 ± 6.11①	48.13 ± 5.93	57.29 ± 6.75①	36.01 ± 4.12	38.69 ± 4.46①

注：①$P<0.05$，与同组治疗前比较；②$P<0.05$，与对照组治疗后比较。

表3 2组脑卒中后失语症患者治疗前后WAB各维度评分比较

Table 3 Comparison of Western Aphasia Battery (WAB) scores in each dimension between the two groups of patients with post-stroke aphasia before and after treatment ($\bar{x}\pm s$, 分)

组别	时间	例数/例	自发言语	听理解	复述	命名
观察组	治疗前	40	91.35 ± 15.35	118.41 ± 17.31	64.38 ± 8.21	47.18 ± 6.24
	治疗后	40	121.38 ± 18.32①②	138.67 ± 20.14①②	78.51 ± 8.62①②	59.74 ± 8.02①②
对照组	治疗前	40	93.65 ± 16.58	116.65 ± 17.62	62.51 ± 7.72	48.24 ± 6.53
	治疗后	40	111.19 ± 17.68①	129.68 ± 18.68①	74.32 ± 7.99①	52.25 ± 7.25①

注：①$P<0.05$，与同组治疗前比较；②$P<0.05$，与对照组治疗后比较。

表4 2组脑卒中后失语症患者治疗前后BDAE等级评分比较

Table 4 Comparison of Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE) severity ratings between the two groups of patients with post-stroke aphasia before and after treatment ($\bar{x}\pm s$, 分)

组别	时间	例数/例	BDAE等级评分
观察组	治疗前	40	1.28 ± 0.60
	治疗后	40	2.95 ± 1.06①②
对照组	治疗前	40	1.20 ± 0.53
	治疗后	40	2.30 ± 1.04①

注：①$P<0.05$，与同组治疗前比较；②$P<0.05$，与对照组治疗后比较。

2.6 2组患者治疗前后中医证候积分比较

表5结果显示：治疗前，2组患者半身不遂、口舌歪斜、不语或言语蹇涩、舌质暗淡中医证候积分比较，差异无统计学意义($P>0.05$)。治疗后，2组患者的半身不遂、口舌歪斜、不语或言语蹇涩、舌质暗淡中医证候积分明显改善($P<0.05$)，且观察组在改善半身不遂、口舌歪斜、不语或言语蹇涩、舌质暗淡中医证候积分方面明显优于对照组，差异有统计学意义($P<0.05$)。

2.7 2组患者治疗前后SAQOL-39g评分比较

表6结果显示：治疗前，2组患者SAQOL-39g各维度评分及总分比较，差异无统计学意义($P>0.05$)。治疗后，2组患者的SAQOL-39g各维度评分及总分均明显改善($P<0.05$)，且观察组在改善SAQOL-39g各维度评分及总分方面明显优于对照组，差异有统计学意义($P<0.05$)。

3 讨论

脑卒中后失语症(PSA)是脑卒中患者治疗后出现的最常见的后遗症之一，本病在中医学中被称为“中风不语”或“舌强语謇”，属于中风病的范畴[16]。语言训练是通过语言不断对患者产生刺激，促使语言功能恢复。但PSA患者不仅语言功能受损，其心理、认知等方面也存在极大障碍，单纯通过语言训练虽可以帮助患者缓慢恢复语言功能，

中国知网 https://www.cnki.net

表5 2组脑卒中后失语症患者治疗前后中医证候积分比较

Table 5 Comparison of TCM syndrome scores between the two groups of patients with post-stroke aphasia before and after treatment

($\bar{x} \pm s$，分)

组别	时间	例数/例	半身不遂	口舌歪斜	不语或言语蹇涩	舌质暗淡
观察组	治疗前	40	2.81 ± 0.31	2.49 ± 0.35	2.37 ± 0.28	2.40 ± 0.30
	治疗后	40	1.54 ± 0.22①②	1.01 ± 0.18①②	1.21 ± 0.20①②	1.19 ± 0.24①②
对照组	治疗前	40	2.68 ± 0.30	2.50 ± 0.32	2.41 ± 0.31	2.37 ± 0.28
	治疗后	40	1.92 ± 0.25①	1.29 ± 0.20①	1.45 ± 0.21①	1.38 ± 0.21①

注：①$P < 0.05$，与同组治疗前比较；②$P < 0.05$，与对照组治疗后比较。

表6 2组脑卒中后失语症患者治疗前后SAQOL-39g评分比较

Table 6 Comparison of SAQOL-39g scale scores between the two groups of patients with post-stroke aphasia before and after treatment

($\bar{x} \pm s$，分)

组别	时间	例数/例	生理	沟通	心理社会	总分
观察组	治疗前	40	43.58 ± 6.29	18.37 ± 3.56	45.29 ± 5.95	107.46 ± 13.52
	治疗后	40	60.31 ± 8.24①②	26.35 ± 3.24①②	59.45 ± 7.59①②	143.27 ± 16.34①②
对照组	治疗前	40	41.37 ± 5.98	19.01 ± 3.24	46.28 ± 6.14	108.37 ± 13.69
	治疗后	40	56.25 ± 7.82①	23.52 ± 3.61①	55.64 ± 7.20①	132.52 ± 15.68①

注：①$P < 0.05$，与同组治疗前比较；②$P < 0.05$，与对照组治疗后比较。

但训练时间较长，患者的依从性大打折扣。因此，探究能够有效帮助脑卒中患者恢复的方法十分必要。

开窍解喑法针刺法是一种适用于中风、脑外伤等导致的失语症、构音障碍等语言功能障碍的治疗方法。石学敏院士在20世纪70年代末提出中风病根本病机在于“肝风挟痰浊、瘀血上蒙脑窍，致窍闭神匿神不导气”，并创立“醒脑开窍”针法，为开窍解喑治法提供了重要基础。本研究结果显示，观察组总有效率为95.00%(38/40)，对照组为80.00%(32/40)，观察组疗效优于对照组，差异有统计学意义($P < 0.05$)。治疗后，2组患者的脑血流速度明显改善($P < 0.05$)，且观察组在改善脑血流速度方面明显优于对照组，差异有统计学意义($P < 0.05$)。治疗后，2组患者的WAB评分、BDAE等级评分明显改善($P < 0.05$)，且观察组在改善WAB评分、BDAE等级评分方面明显优于对照组，差异有统计学意义($P < 0.05$)。治疗后，2组患者的中医证候积分、SAQOL-39g评分明显改善($P < 0.05$)，且观察组在改善中医证候积分、SAQOL-39g评分方面明显优于对照组，差异有统计学意义($P < 0.05$)。结果表明，开窍解喑法针刺可提高PSA的临床疗效。而半身不遂、口舌歪斜、不语或言语蹇涩、舌质暗淡4个方面是PSA患者最主要的症状，治疗后，2组患者中医证候积分明显改善。分析其原因：开窍解喑法针刺通过刺激特定的穴位，疏通经络，促进气血运行，从而改善半身不遂、口舌歪斜等症状，并可加速气血运行，改善因血气不畅引起的舌质暗淡[17]。而语言训练可通过反复刺激大脑的语言中枢，促进神经元的再生和连接，增加神经系统的可塑性，提高神经系统的活跃度，改善不语或言语蹇涩等症状，促进语言功能功能[18]。开窍解喑法针刺联合语言训练，二者结合促进患者语言功能的恢复。内关具有养心安神，通调气血之功，针刺内关可调节脏腑气血功能，促进气血运行，因此，脑血流速度会加快。脑血流速度加快可有助于神经元的再生和修复，为受损的语言网络提供更好的支持，改善失语症；而针刺百会、风池、天突、通里、廉泉、旁廉泉等穴位，可开窍醒脑，帮助患者语言功能恢复[19]。BDAE是对PSA的程度进行评判的等级标准，BDAE评分越低，表示患者失语症越严重。治疗后，患者失语症严重程度大大缓解，可促进患者语言功能恢复。患者失语症情况恢复越好，患者恢复自信心越足，能减轻患者因语言障碍产生的心理压力，有助于整体康复，提高患者生活质量。因此，SAQOL-39g各维度评分及总分在联合治疗后会大大提升。针刺通过刺激穴位调

中国知网 https://www.cnki.net

节脑部气血运行，改善脑部微循环和神经功能，促进受损神经功能恢复，为言语功能的改善提供生理基础，而语言训练则针对性地激活大脑语言中枢区域，强化神经功能重建，通过反复练习促进语言能力的恢复，两者相辅相成，共同促进患者言语表达和理解能力的提升[20-21]。

综上所述，开窍解喑法针刺联合语言训练治疗PSA，能够明显提高患者的脑血流速度，改善患者的临床症状及失语症严重程度，促进患者语言功能的恢复，从而提高患者的生活质量，疗效确切，值得在临床进一步推广应用和深入研究。

参考文献：

[1] EDELKRAUT L，LÓPEZ-BARROSO D，TORRES-PRIORIS M J，et al.Spectrum of neuropsychiatric symptoms in chronic post-stroke aphasia[J]. World J Psychiatry，2022，12(3)：450-469.

[2] GEORGIOU A M，KAMBANAROS M. Therapies and challenges in the post-stroke aphasia rehabilitation arena：current and future prospects[J]. Medicina (Kaunas)，2023，59(9)：1674.

[3] VARKANITSA M，GODECKE E，KIRAN S. How much attention do we pay to attention deficits in poststroke aphasia?[J]. Stroke，2023，54(1)：55-66.

[4] 孙宁，秦丽萍. 音乐疗法联合语言训练素材干预对脑卒中合并失语症患者ABC评分的影响[J]. 检验医学与临床，2020，17(24)：3640-3642.

[5] 陈文雅，郭培，张微微，等. 针刺联合低频重复经颅磁刺激治疗脑卒中后失语症的效果[J]. 宁夏医科大学学报，2022，44(3)：281-285.

[6] 芮锦伟，区淑娟，权元鼎，等. 圣愈汤联合针刺对缺血性脑卒中后失语症患者语言功能及生活质量的影响[J]. 现代中西医结合杂志，2020，29(35)：3920-3924，3928.

[7] 卫建华，蒋同伯，许敏，等. 针刺联合语言训练对缺血性中风后运动性失语患者语言功能及脑血流的影响[J]. 针灸推拿医学(英文版)，2021，19(5)：378-383.

[8] 彭斌，吴波. 中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018[J]. 中华神经科杂志，2018，51(9)：666-682.

[9] 高素荣. 失语症[M]. 2版. 北京：北京医科大学出版社，2006：593.

[10] 国家中医药管理局. 中医病证诊断疗效标准[M]. 南京：南京大学出版社，1994：164.

[11] 郑筱萸. 中药新药临床研究指导原则(试行)[M]. 北京：中国医药科技出版社，2002：233-234.

[12] 汉语失语症康复治疗专家共识组. 汉语失语症康复治疗专家共识[J]. 中华物理医学与康复杂志，2019，41(3)：9.

[13] 汪洁，张清丽，吕焱玲，等. 波士顿诊断性失语症检查汉语版的编制与常模[J]. 中国康复，1996，11(2)：49-51.

[14] HILARI K，LAMPING D L，SMITH S C，et al. Psychometric properties of the Stroke and Aphasia Quality of Life Scale (SAQOL-39) in a generic slroke population[J]. Clin Rehabil，2009，23(6)：544-557.

[15] 尚郁峰，朱金妹，钱贞，等. 中药穴位熏蒸联合镜像神经元康复训练治疗中风后失语症疗效观察[J]. 上海针灸杂志，2020，39(3)：285-290.

[16] 陈健林，傅晓峰，倪新元，等. 百会八阵穴联合圣愈汤对脑卒中后失语症患者的疗效及脑血流的影响[J]. 中国中医急症，2023，32(9)：1583-1586.

[17] 李昭缘，林万隆，齐瑞. “开窍解喑”法针刺联合重复经颅磁刺激治疗卒中后失语症：随机对照试验[J]. 中国针灸，2023，43(1)：25-28.

[18] 何青，戴碧华，刘益，等. 中风后失语症三联疗法临床疗效观察[J]. 时珍国医国药，2021，32(5)：1167-1168.

[19] 高洋，黄岩，刘培培，等. 言语康复训练联合督脉针刺合舌三针对卒中失语患者语言功能认知水平的影响[J]. 安徽医学，2024，45(6)：714-718.

[20] 陈晓燕，王玉龙，王光益，等. “醒脑开喑法”针刺联合言语训练治疗脑卒中失语症的疗效观察[J]. 中西医结合心脑血管病杂志，2021，19(7)：1194-1196.

[21] 关玉杰，庞青民，王承惠. 针刺联合语言康复训练对中风后失语患者语言功能及血液流变学指标的影响[J]. 新中医，2022，54(23)：159-163.

【责任编辑：宋威，刘彦宜(英文)】

中国知网 https://www.cnki.net